

Un trabajador autista en su equipo de salud laboral

Para enfermeros de salud laboral y personal de salud en el lugar de trabajo — apoyar a un adulto autista empleado.

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un adulto se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. Los lugares de trabajo —planta abierta, ruidosos, llenos de interrupciones y reglas no escritas— provocan el camuflaje y el **burnout autístico**, que es distinto del estrés profesional ordinario y la depresión. Como enfermero de salud laboral, usted está en una posición privilegiada para detectarlo, separarlo de los problemas de rendimiento y gestionar los ajustes razonables que mantienen a un trabajador capaz sano y en su puesto.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Agotado, pierde habilidades, no puede recuperarse tras el trabajo	Burnout autístico — distinto del burnout profesional y la depresión
«Está bien» en la clínica, colapsa durante días después	Camuflaje pesado; una visita de 15 minutos rara vez muestra el coste
No reporta el dolor, los síntomas o los efectos secundarios hasta que son severos	Diferencias de intérocepción
Conflictos vinculados a la planta abierta, las reuniones, el puesto rotativo	Un problema de encaje con el entorno, no un problema de competencia
Quiere todo por escrito; evita las llamadas	La comunicación de canal único reduce la carga

Intente esto

- **Ofrezca la herramienta AASPIRE AHAT** antes de la visita y opciones que **prioricen el escrito**; permita la presencia de un acompañante.
- **Reconozca el burnout autístico** y no lo confunda con la depresión o una «mala resiliencia».
- **Gestione los ajustes razonables**: espacio tranquilo, instrucciones escritas, menos reuniones, comunicación asíncrona, expectativas definidas.
- **Comience la medicación a dosis bajas y titule lentamente** — las respuestas sensoriales/emocionales atípicas son comunes.
- **Documente los ajustes efectivos** para que sean automáticos la próxima vez.

Evite esto

- Dejar que una visita calmada y camuflada anule la auto-declaración y el historial.
- Tratar el burnout como depresión y presionar con un plan de «retorno a la carga completa».
- Assimilar el hecho de «no quejarse» con «no sufrir».

Cuándo buscar más apoyo

Evalúe la **suicidalidad** — el burnout está vinculado a ella. Aborde las **co-ocurrencias de TDAH (AuDHD), ansiedad, depresión, problemas de sueño y GI**. Cuando el burnout es severo, valide el retorno progresivo, la reducción de horas o un cambio de rol como recuperación.

If the worker is a woman

Las mujeres diagnosticadas tardíamente camuflan más intensamente; tome en serio un patrón de vida de diferencia y sobrecarga, incluso con un exterior «de alto rendimiento».

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.4 & 4) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un herramienta de diagnóstico**. Adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Las citas completas están en los borradores fuente.